

Willen versus Moeten: De invloed van motivatie op het therapeutisch proces

Joke Verstuyf

Maarten Vansteenkiste

Universiteit Gent

Verstuyf, J., & Vansteenkiste, M. (2008). Willen versus moeten: De invloed van motivatie op het therapeutisch proces. *Agora*, 24, 7-22.

Correspondentie omtrent dit artikel kan gezonden worden naar: Joke Verstuyf of

Maarten Vansteenkiste, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent; E-mail: Joke.Verstuyf@ugent.be;

Maarten.Vansteenkiste@ugent.be

Inleiding

De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000) is een motivationele theorie die vertrekt vanuit een positieve visie op de mens. Mensen zouden de aangeboren kracht bezitten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Deze kracht kan door de omgeving worden gestimuleerd of worden tegengewerkt. Net deze uitgangspositie maakt deze theorie zo boeiend en relevant, ook voor de praktijk. Mensen zijn niet louter een passief product van hun omgeving; er is een samenspel tussen een op groei gerichte persoon en de omgeving. Dit samenspel zorgt ervoor dat een mens het beste van zichzelf geeft en excelleert dan wel passief en gelaten wordt, waarbij hij geleidelijk aan van zichzelf en deze interne groeikracht vervreemdt.

De ZDT heeft in zijn opgang een andere evolutie doorgemaakt dan vele andere klinische geïnspireerde motivatietheorieën, zoals bijvoorbeeld motivationeel interviewen (Miller & Rollnick, 2002) en het transtheoretisch model van verandering (Prochaska & DiClemente, 2002). Deze beide theorieën zijn vanuit de ervaring in het klinische veld (“bottom up”) gegroeid. Ze worden enthousiast door begeleiders en clinici onthaald omdat ze het motivationeel functioneren van mensen goed weten te beschrijven of omdat ze concrete tips en handvaten bieden om cliënten te motiveren. Deze theorieën delen bijvoorbeeld de stelling dat de motivatie van de cliënt beter van “binnen” komt dan van “buiten” om een gedragsverandering over langere tijd te bevorderen. Kortom, deze theorieën sluiten goed aan bij het buikgevoel en de dagelijkse praktijk en noden van hulpverleners en opvoeders.

De ZDT onderging een andere evolutie: veeleer dan te groeien vanuit de praktijk ontstond deze theorie vanuit het labo (Deci, 1971). In dergelijke labo-studies werd nagegaan wat de beste wijze was om personen optimaal te motiveren. In de jaren 1980

en 1990 werden nieuwe puzzelstukjes aan de theorie toegevoegd, waarbij de theorie geleidelijk aan werd toegepast op en onderzocht in verschillende levensdomeinen. Op deze manier begon de ZDT meer en meer ingang te vinden in de praktijk. Zo blijkt de toepassing van deze theorie motiverend te zijn voor leerlingen in het middelbare en hoger onderwijs (zie bijv. Lens, & Depreeuw, 1998; Vansteenkiste, Sierens, Soenens, & Lens, 2007), voor werkenden en werkzoekenden (zie bijv., Vansteenkiste, Lens, Dewitte, De Witte, & Deci, 2004), bij de opvoeding van kinderen (Grolnick, 2003), voor cliënten met eetstoornissen (zie bijv. Vansteenkiste, Soenens, & Vandereycken, 2005), en ook voor cliënten met gedrag- en verslavingsproblemen (zie bijv. Ryan, Plant, & O'Malley, 1995; Wild, Cunningham, & Ryan, 2006; zie www.psych.rochester.edu/SDT voor een overzicht). Deze “top down” evolutie van de theorie zorgt ervoor dat het conceptueel kader dat werd opgebouwd meer verfijnd is. Deze verfijning is noodzakelijk én nuttig: het laat immers toe om een meer genuanceerd inzicht te verwerven in het motivationeel functioneren van mensen en de wijze waarop de omgeving op deze motivatie kan inspelen. De theoretische verfijning heeft dus een grote praktische relevantie.

In dit opzicht is het ook interessant om vast te stellen dat de ZDT sinds de eeuwwisseling meer en meer in verband wordt gebracht met klinisch-motivationele theorieën, die goed aansluiten bij de intuïtie van begeleiders en clinici (bijv., Rollnick et al., 2005; Vansteenkiste & Sheldon, 2005). Men ziet in dat “bottom up” en “top down” benaderingen op een zinvolle wijze kunnen geïntegreerd worden; ze bevruchten elkaar wederzijds. In deze bijdrage proberen we de meerwaarde van de ZDT voor de praktijk aan te tonen. Dit doen we door te vertrekken van een aantal vragen en stellingen, die

hulpverleners in de BJZ er op nahouden. Deze worden dan afgetoetst ten opzichte van datgene wat hierover binnen de ZDT wordt gesteld.

Wat is Goede Motivatie en een Gebrek aan Motivatie?

Goede Motivatie

Mark Tack (agora 23, nr. 5 pp27) geeft aan dat gemotiveerd zijn voor velen betekent dat 'men zelf iets wil'. Wat betekent zelf willen echter? Wat kan hier precies onder begrepen worden? Verwijst dit naar één welbepaald type motivatie of naar meerdere types motivatie?

Vele clinici en begeleiders zouden 'zelf willen' waarschijnlijk gelijkstellen aan intrinsieke of interne motivatie. Intrinsieke motivatie tot verandering zou goed zijn, omdat de motivatie vanuit de persoon komt; de verandering is zelfgewild. Intrinsieke motivatie onderscheidt zich dan van extrinsieke motivatie, omdat in dit geval de motivatie van buitenaf komt; er wordt aan het probleem gewerkt omdat het moet.

Ook in de ZDT wordt het verschil tussen moeten en willen gemaakt, maar extrinsieke motivatie staat niet gelijk aan 'moeten' en intrinsieke motivatie niet gelijk aan 'willen'. Bij intrinsieke motivatie stelt men een gedrag omdat men er plezier aan beleeft. Het gedrag is het doel op zich. Bij extrinsieke motivatie, stelt men een bepaald gedrag om er iets anders mee te bekomen. Er bestaan verschillende types of vormen van extrinsieke motivatie, waarvan sommige onder 'willen' vallen en andere onder 'moeten'. Het onderscheid tussen deze verschillende types extrinsieke motivatie is belangrijk voor het motiveren van cliënten, omdat deze verschillende effecten met zich meebrengen. Terwijl sommige types extrinsieke motivatie bijvoorbeeld samenhangen met het volhouden van een in therapie op gang gebrachte verandering is dat niet het geval voor andere types extrinsieke motivatie.

Even een woordje uitleg. Binnen de ZDT worden de volgende drie types extrinsieke motivatie onderscheiden (zie Figuur 1): externe verplichting, interne verplichting en persoonlijk belang. *Externe verplichting* is waarschijnlijk het meest bekende type van extrinsieke motivatie. Hierbij wordt het gedrag uitgevoerd om straf te vermijden, om aan externe verwachtingen te voldoen of om een vooropgestelde beloning te verkrijgen. Zo kan een jongere in therapie gaan om een grotere straf vanwege de jeugdrechter te vermijden. Een jongere kan zich in een therapeutische instelling aan de “huisregels” houden, zoals de verwachting om je kamer op te ruimen, omdat hij/zij anders niet meer mag roken. Als clinici over extrinsiek gemotiveerde cliënten spreken, dan hebben ze meestal dergelijke voorbeelden voor ogen. Binnen de motivatiepsychologie wordt gesteld dat dit allen voorbeelden zijn van externe verplichting, omdat het uitvoeren van het gedrag in een dergelijk geval gepaard zal gaan met een gevoel van verplichting en druk, wat stress met zich mee kan brengen. De beoogde gedragsverandering wordt in een dergelijk geval helemaal gestuurd door externe factoren.

De druk tot verandering hoeft echter niet noodzakelijk van buiten uit te komen. Een cliënt kan ook zichzelf druk opleggen om te veranderen. Zo zou een jongere in therapie kunnen gaan omdat hij wil tonen aan zijn ouders of aan zichzelf dat hij, na herhaaldelijke mislukkingen, toch in staat is om zijn drugsprobleem op te lossen. Hij zal nu de “huisregels” volgen om schuld-, schaamte- en angstgevoelens te vermijden. Dit tweede type extrinsieke motivatie wordt omschreven met de term *interne verplichting*. De motivatie voor het uitvoeren van het gedrag, die aanvankelijk van buiten af kwam, bevindt zich nu in de persoon. De patiënt heeft een interne versie gevormd van de kritische stem, die hem aanvankelijk motiveerde tot gedragsverandering.

Gedragsverandering wordt nu nagestreefd om tegemoet te komen aan deze interne verplichting. Hoewel intern gemotiveerd zal de activiteit, net als bij externe verplichting, uitgevoerd worden met een gevoel van verplichting en stress, omdat ze gepaard gaat met een intern conflict. Net omwille van deze reden worden externe verplichting en interne verplichting binnen de ZDT samengebracht onder de noemer ‘gecontroleerde motivatie’, ofwel het nastreven van verandering omdat ‘het moet’.

Een derde vorm van extrinsieke motivatie kan omschreven worden met de term *persoonlijk belang*. Cliënten zullen in een dergelijk geval in therapie gaan of zullen de “huisregels” naleven omdat ze deze persoonlijk relevant vinden. Ze herkennen zich in regels, ze zien er het nut en de noodzaak van in. Zo kan een jongere in therapie gaan omdat hij beseft dat hij de controle over zijn drugsgebruik kwijt is. Om aan zijn drugs te komen moet hij liegen tegen zijn vrienden en familie en dit wil hij niet langer. Net daarom wil hij stoppen met drugs te nemen. Hij zal zich aan de “huisregels” houden omdat hij inziet dat de regels nodig zijn om de nodige structuur in de afdeling te brengen; anders verloopt alles chaotisch en is therapeutisch werk bijna onmogelijk. In het geval van persoonlijk belang zal de activiteit, verschillend van interne en externe verplichting, met een gevoel van psychologische vrijheid en keuze worden uitgevoerd; men is immers persoonlijk overtuigd van de uit te voeren activiteit of de na te leven regels.

Deze drie types motivatie, namelijk externe verplichting, interne verplichting, en persoonlijk belang zijn alle drie types van extrinsieke motivatie: in alle drie de gevallen wordt de activiteit immers uitgevoerd om iets anders te bekomen. Als men nu de huisregels volgt omdat men dan pas geapprecieerd wordt (externe verplichting), omdat dit de morele plicht is van jongeren om dit te doen (interne verplichting), of omdat men

van het nut ervan overtuigd is en dus met de regels akkoord gaat (persoonlijk belang), in elk van deze drie gevallen dient de activiteit een doel. Omwille van deze reden vormen dit drie types extrinsieke motivatie.

Deze drie types extrinsieke motivatie kunnen van elkaar onderscheiden worden aan de hand van de mate waarin de reden voor het stellen van het gedrag persoonlijk werd aanvaard of, technisch gesteld, werd geïnternaliseerd. Het proces van internalisatie of *persoonlijke aanvaarding* verwijst naar de mate waarin initieel van buiten uit aangereikte overtuigingen, waarden en gedragingen werden omgevormd tot persoonlijk gewaardeerde overtuigingen, waarden of gedragingen (Deci & Ryan, 1985). In het geval van externe verplichting is de reden tot het stellen van het gedrag helemaal niet persoonlijk aanvaard. In het geval van interne verplichting werd deze gedeeltelijk aanvaard, terwijl dit helemaal het geval is bij persoonlijk belang. Kortom, de drie types extrinsieke motivatie kunnen gesitueerd worden op een (ontwikkelingspsychologisch) continuüm van toenemende persoonlijke aanvaarding.

Zoals vermeld wordt ook intrinsieke motivatie als een vorm van motivatie onderscheiden binnen de ZDT. In het geval van intrinsieke motivatie, *passie* of *spontane geboeidheid* zal men de activiteit niet uitvoeren om een doel te bereiken dat buiten de activiteit ligt, zoals dit bij extrinsieke motivatie het geval is, maar is de activiteit doel op zich. De activiteit zelf en meer bepaald het plezier en de voldoening die de activiteit verschaft is de reden om de activiteit uit te voeren. Met andere woorden: men hoeft de waarde of het belang van de activiteit niet te aanvaarden en toch zal men het gevoel hebben de activiteit met een gevoel van vrijheid en keuze uit te voeren. Men voelt zich immers spontaan aangetrokken tot de activiteit, die aansluit bij de eigen interesses. Daarom staat passie ook helemaal rechts in Figuur 1.

Binnen de ZDT worden dus twee types drijfveren onderscheiden die allebei gekenmerkt worden door een gevoel van psychologische vrijheid, namelijk *persoonlijk belang* en *passie*. Daarom worden ze vaak samen geplaatst onder de noemer ‘autonome motivatie’, ofwel het nastreven van verandering omdat men ‘het zelf wil’. Autonome motivatie wordt dan gecontrasteerd met gecontroleerde motivatie, dat ook twee subtypes bevat, namelijk externe en interne verplichting.

Dit brengt ons opnieuw bij onze uitgangsstelling en de vraag wat de precieze betekenis is van zelfgewilde motivatie. In de kliniek bestaat de overtuiging dat zelfgewilde verandering en motivatie het beste is. De ZDT sluit zich hier helemaal bij aan en geeft aan dat die zelfgewilde motivatie twee componenten bevat: passie en persoonlijk belang. In therapie zal het vooral de taak zijn van de begeleider om de persoonlijke overtuiging van de verandering te verhogen; cliënten vinden in therapie gaan immers zelden tot nooit plezierig, laat staan dat ze er door gepassioneerd zouden raken. Tegelijk zal het de taak zijn van begeleiders en hulpverleners om geen verplichting tot verandering aan te praten. Merk op dat deze verplichting niet enkel door de begeleider of door de instelling kan aangewakkerd worden, die bijvoorbeeld dreigt met een straf, maar dat cliënten zichzelf ook onder druk kunnen zetten. Interne schuldgevoelens, waarop door de omgeving weliswaar ook vaak wordt ingespeeld, kunnen de cliënt onder druk zetten om de therapie vol te houden. Opgeven betekent immers dat men zwak is en geen karakter heeft.

Samengevat: “willen” versus “moeten” veranderen vormen de twee kernbegrippen binnen de ZDT. Deze begrippen vallen echter niet samen met de concepten extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Er bestaan immers verschillende types extrinsieke motivatie: terwijl interne en externe verplichting twee

types extrinsieke motivatie zijn die tot de categorie 'moeten' behoren is persoonlijk belang een type extrinsieke motivatie die tot de categorie 'willen' behoort. Net hierom is het klassieke onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie vervangen door het onderscheid tussen gecontroleerde (moeten) en autonome (willen) motivatie.

Wat is een Gebrek aan Motivatie?

Verschillende types motivatie, het klinkt allemaal mooi. Maar meer dan gemotiveerd zijn vele jongeren in de BJZ niet gemotiveerd om iets aan hun problemen te doen. Ze vertonen een lage mate van motivatie. Hoe kan dit gebrek aan motivatie dan begrepen worden, want dit is misschien nog relevanter voor de dagelijkse praktijk?

In sommige gevallen zal deze lage hoeveelheid motivatie samenhangen met een gebrek aan geloof in het eigen kunnen om de problemen op te lossen, of daar een aanzet tot te doen. Dit gebrekkige zelfvertrouwen zorgt ervoor dat sommige jongeren passief en lusteloos blijven. Binnen de ZDT wordt gezegd dat ze *hulpeloos* zijn geworden, omdat ze na vele mislukte pogingen hebben geleerd dat hun pogingen om aan hun problemen te werken in het niets stranden. Deze hulpeloze jongeren onderscheiden zich van jongeren die werken aan hun problemen omdat het moet of omdat ze het zelf willen. Terwijl de laatste twee groepen gemotiveerd zijn en hun gedrag gericht is op het bereiken van een gewenste uitkomst, is de eerste groep niet gemotiveerd. Hun gedrag is niet gericht op het neerzetten van een specifiek gedragsresultaat, omdat ze er niet in geloven dat ze dankzij hun inspanningen dit gedragsresultaat kunnen bereiken. Een drugsverslaafde jongere kan bijvoorbeeld tijdens verschillende ambulante behandelingen ondervonden hebben dat hij tijdelijk zijn drugsgebruik kan minderen, maar dat hij na verloop van tijd opnieuw hervalt. Als hij dan in behandeling komt in een residentiële instelling kan hij het geloof opgegeven hebben dat hij ooit clean zal worden.

Het heeft geen zin om zo'n langdurige behandeling te starten, want hij zal toch hervallen in zijn oude problemen. Een dergelijke jongere is hulpeloos geworden.

Toch zijn er nog andere redenen dan hulpeloosheid te bedenken waarom jongeren in de BZJ niet aan hun problemen werken. Sommige jongeren vertonen een grote weerstand tot verandering; ze zijn heel weerspanning en gaan zich vaak verzetten tegen elk initiatief of voorstel van begeleiders. Zo vinden ze dat begeleiders in een instelling hen met al hun voorgestelde "huisregels" betuttelend behandelen; ze zijn ten slotte geen kinderen meer en verzetten zich tegen de huisregels. Of ze vinden dat ze gewoon geen probleem hebben en dat de externe omgeving gewoon overdrijft. Ze zijn uiteindelijk oud genoeg om zelf te beslissen wat ze met hun leven willen aanvangen.

Terwijl hulpeloze jongeren nog een inzicht hebben in hun gedrag en hun problemen onderkennen, is dit vaak niet het geval voor rebellerende jongeren. Dit verzet kan echter, net zoals de motivatie om een bepaalde activiteit wel uit te voeren, gemotiveerd zijn door verschillende redenen. Binnen de ZDT wordt gesteld dat zowel het inwilligen als niet-inwilligen van een verzoek gecontroleerd en autonoom gemotiveerd kan zijn.

Laat ons hier even verder op ingaan. Sommige jongeren verzetten zich botweg tegen elk externe autoriteit; ze hebben problemen met gezag en willen niet dat anderen hen vertellen wat ze dienen te doen. Ze voelen zich snel gecontroleerd en gestuurd in hun functioneren; ze hebben volgens hen ook geen probleem en zullen dus een hoge weerstand vertonen tegen verandering. Hierbij gaan ze waarschijnlijk vaak in conflict met anderen, omdat ze zich ruwweg verzetten zich tegen extern gecommuniceerde verwachtingen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit gepaard gaan met het uiten van openlijke fysieke of verbale agressie tegenover hulpverleners, die vaak op een respectloze wijze

worden behandeld. Een dergelijke houding zal waarschijnlijk de kwaliteit van de therapeutische relatie sterk ondermijnen, wat op zijn beurt bijdraagt tot een verminderde vooruitgang tijdens therapie.

In andere gevallen is dit verzet tegen de huisregels of het stellen van een bepaald gedrag gemotiveerd door interne verplichtingen. Sommige jongeren gaan bijvoorbeeld niet in behandeling omdat ze bang zijn wat de buitenwereld wel van hen zou denken; het zou betekenen dat ze dienen te erkennen dat ze problemen hebben en ze willen net als sterk gezien worden. Eén maal in therapie zullen sommige jongeren zich niet houden aan de opgedragen regels (bijv. niet roken op de kamer), omdat ze een stoere indruk willen maken op de anderen, of omdat ze willen vermijden om als een “doetje” bekeken te worden door hun leeftijdsgenoten. Ze zouden beschaamd zijn als ze braaf de opgedragen regels zouden volgen en ze zijn bang om de waardering van hun kameraden verliezen. Omdat leeftijdsgenoten en het vormen van “peergroepen” in de adolescentiejaren heel belangrijk zijn is het aannemelijk dat het niet ingaan op een verzoek van hulpverleners wel eens gemotiveerd is door een interne verplichting.

Of het nu gaat om een bot verzet tegen externe autoriteiten of een verzet dat gemotiveerd is door interne verplichtingen, in deze beide gevallen is het niet uitvoeren van de activiteit gecontroleerd van aard. Men heeft het gevoel dat men geen andere keuze heeft dan zich te verzetten en het opgedragen verzoek niet in te willigen.

Het niet inwilligen van een verzoek of het niet naleven van de huisregels kan echter ook gemotiveerd zijn door keuze. Soms zullen jongeren, hoewel ze goed weten welke sancties er volgen als ze de regels overtreden, oordelen dat het in een bepaalde situatie gerechtvaardigd is om de regels te overtreden. Ze hebben zelf goede argumenten om zich niet aan de vooropgestelde regels te houden of niet in te gaan op het

voorgestelde verzoek. In plaats van zich botweg te verzetten tegen een verzoek zullen dergelijke jongeren eerder het verzoek in vraag stellen. Ze beginnen te discussiëren over de waarde en het nut van het verzoek. Hierbij zullen ze zich waarschijnlijk minder agressief opstellen dan jongeren die het verzoek niet inwilligen omwille van gecontroleerde redenen. Ze zullen eerder vanuit een respect voor de begeleiding in een constructief gesprek gaan, waarbij ze zelf ook proberen uit te leggen waarom ze (zouden) weigeren op het verzoek in te gaan. Ze handelen op een authentische wijze en een dergelijk oprecht functioneren zal anders ervaren worden dan het ruwe verzet van jongeren die omwille van gecontroleerde redenen het verzoek niet inwilligen. Het is dan ook aannemelijk dat een dergelijke weigering niet noodzakelijk de therapeutische relatie ondermijnt; begeleiders zouden zelfs eerder respect hebben voor de jongere omdat deze op een beleefde en oprechte wijze uitkomt voor de eigen mening. Omdat het niet inwilligen van een dergelijk verzoek gekenmerkt wordt door authenticiteit en een gevoel van psychologische vrijheid, kan gesteld worden dat het autonoom gemotiveerd is.

Samengevat: minstens drie verschillende motieven kunnen onderscheiden worden voor het niet stellen van een gewenst gedrag: hulpeloosheid, het gecontroleerd of verplicht en het vrijwillig of autonoom weigeren van het gewenste gedrag. Het is aannemelijk dat hulpeloze jongeren die toch een inspanning leveren, dit zullen doen omdat het 'moet'. Ze hebben geen andere keuze volgens hen. In de mate dat ze een gedrag weigeren te stellen zal dit waarschijnlijk ook eerder gecontroleerd gemotiveerd zijn. Ze verzetten zich botweg, want het heeft volgens hen toch geen zin om een inspanning te leveren, omdat hun problemen niet zijn op te lossen.

Waarom is motiveren belangrijk?

Het gegeven dat hulpverleners enkel ‘iets zelf willen’ als motivatie beschouwen, geeft aan dat begeleiders en deskundigen aanvoelen dat zelf willen veranderen van een betere kwaliteit is dan moeten veranderen. In de praktijk van de hulpverlening ligt motiveren echter vaak heel moeilijk. Hans Paredis geeft in *agora 23, nr.5* weer dat motiveren vaak betekent dat men sleurt en trekt aan de jongere om veranderingen te weeg te brengen die dringend nodig zijn in het belang van de jongere. Als de jongere deze veranderingen zelf niet wil, dan levert dit bij de hulpverleners vaak grote frustratie op, waardoor men zich kan gaan afvragen of moeten dan toch niet soms beter is dan de jongere te motiveren.

“Soms vraag ik me af of het in zware problematische situaties soms niet meer oplevert om te stoppen met motiveren en gewoon te zeggen ‘het moet’ (van mij, van je ouders, van de jeugdrechter, ..). Moeten heeft alvast twee voordelen: het is duidelijker en er worden minder woorden aan vuil gemaakt.”

(Hans Paredis, agora 23, nr. 5 pp24)

Hoewel ‘moeten’ misschien wel deze twee voordelen heeft, gaat het gepaard met een uiterst belangrijk nadeel: het garandeert helemaal geen succes en zeker niet op lange termijn. Hoewel moeten ook een vorm van motivatie is, is het immers een kwalitatief minder goed type motivatie dan willen. Zowel bij opgelegde als zelfgekozen verandering wordt een aanzet gedaan en een inspanning geleverd om het gedrag te veranderen. De nagestreefde gedragsverandering staat in het geval van ‘moeten’ echter onder controle van een extern verplichtende instantie (vb., een straffende begeleiding) of van een interne verplichting (vb., knagend schuldgevoel), terwijl het in het geval van ‘willen’ voortvloeit uit of aansluit bij de persoonlijke waarden, ideeën en overtuigingen van de jongere. Hoewel moeten misschien een kortstondige gedragsverandering met zich mee kan brengen, gaat het niet gepaard met langdurige verandering omdat de

verandering niet persoonlijk wordt onderschreven door de jongere maar veeleer als controlerend en verplichtend wordt ervaren. We proberen dit te verduidelijken met een voorbeeld:

“De 15-jarige Tom heeft altijd al een ‘moeilijk’ karakter gehad. Hij voelt zich gemakkelijk aangevallen, waarna hij zich agressief opstelt. In het weekend neemt Tom drugs, waardoor hij nog agressiever wordt en hij betrokken geraakt in ruzies en vechtpartijen met andere jongeren. Als Tom na de zoveelste vechtpartij wordt opgepakt door de politie, wordt hij doorverwezen naar de jeugdrechter. Het verdict van de rechter is een opname in een instelling voor 3 maanden. Tom vindt dat hem geen schuld treft. Het waren de andere jongeren die het gedrag bij hem uitlokten. Hij vindt het dan ook oneerlijk en nutteloos dat hij naar een instelling moet gaan. Onder druk van een verdere gerechtelijke sanctie start hij dan toch de therapie. Tijdens de therapeutische sessies zit Tom zijn tijd uit en hoewel hij de verschillende “huisregels” bij het toezien van de opvoeders en therapeuten volgt, lapt hij deze aan zijn laars als de begeleiders niet langer in de buurt zijn. Als een begeleider op een gegeven moment Tom bij het overtreden van de huisregels onverwacht vat, mag Tom de volgende drie dagen niet roken. Tom verzet zich sterk tegen deze sanctie. Hij scheldt de begeleider uit en trekt zich, ondanks het verbod, terug in zijn kamer om er te roken. De opvoedkundige is Tom’s gedrag meer dan beu en sanctioneert hem later die dag voor het negeren van de sanctie. De situatie escaleert de dagen nadien heel snel tot op een punt dat Tom zijn therapie staakt en er van door gaat.”

De jongere in deze casus gaat in therapie omdat hij hiertoe door het gerecht wordt verplicht; zijn gedrag staat onder controle van externe verplichtingen. Deze ervaren externe druk om te werken aan zijn problemen zal zich al snel laten voelen in

het weerspannig volgen van de huisregels; ook deze worden door Tom immers als extern verplichtend ervaren. Hij ziet er het nut niet van in. Tom lijkt in de instelling dan ook enkel de huisregels te gehoorzamen als er begeleiders in de buurt zijn. Anders gesteld, de gedragsverandering blijft beperkt tot de situaties waarin de verandering hem opgelegd wordt. Tom gedraagt zich als zijn gedrag wordt geobserveerd, maar hervalt in zijn oude gewoontes als het toezicht wegvalt. Er is dus een gebrek aan het volhouden van het opgedragen gedrag. Bovendien blijkt Tom zich te verzetten tegen zijn externe begeleiders. Hij voelt zich snel aangevallen en stelt zich agressief op. Dit wijst er op dat in de mate dat hij niet de vooropgestelde regels volgt, hij dit eerder doet omwille van gecontroleerde redenen. Kortom, het 'moeten' veranderen geeft aanleiding tot het gebrekkig volhouden van de opgedragen gedragsverandering en een grotere mate van botverzet en agressieve opstelling tegen autoriteitsfiguren.

Ook bij interne verplichting is de gedragsverandering tijdelijk. De jongere zal een inspanning leveren om het gewenste gedrag vol te houden, maar hij dient zichzelf voortdurend onder druk te zetten en aan te manen om het gedrag uit te voeren. Dit vergt heel wat energie: langs de ene kant is er immers een interne verplichting om het gedrag uit te voeren (om zo bijvoorbeeld gevoelens van schuld en schaamte te onderdrukken), maar anderzijds heeft men geen zin om te veranderen aangezien de activiteit niet persoonlijk gewaardeerd wordt (Vansteenkiste, et. al., 2007). Deze interne spanningsverhouding is emotioneel uitputtend, waardoor de op gang gebrachte verandering onder interne druk minder langdurig wordt volgehouden en meer irritatie en negatieve gevoelens opwekt dan in het geval wanneer de verandering uit persoonlijke overtuiging wordt nagestreefd. Merk op dat interne verplichting, hoewel het een vorm

van interne motivatie representeert, dus ook verondersteld wordt nadelige effecten met zich mee te brengen.

Onderzoek bevestigt deze vaststellingen: moeten veranderen gaat gepaard met een grotere mate van weerstand en minder medewerking (bijv., Miller, Benefield, & Tonnigan, 1993), meer afleiding en spanning tijdens therapeutische sessies (bijv., Pelletier et al., 1997) en meer drop-out tijdens behandeling (bijv., Zeldman, Ryan, & Fiscella, 2004). Daarentegen heeft willen veranderen veel duurzamere effecten in de zin dat de kans op herval veel kleiner is (Ryan, Plant, & O'Malley, 1995). Een dergelijke gedragsverandering zal bovendien gepaard gaan met een grotere medewerking tijdens therapie (Wild, Cunningham, & Ryan, 2006), een meer positieve gemoedsgesteltenis tijdens therapie (Pelletier, Tuson, & Haddad, 1997) en een verhoogd welzijn (Senecal, Nouwen, & White, 2000), omdat de cliënt de therapie met een groter gevoel van vrijheid beleeft. Een autonoom gemotiveerde cliënt zal meer progressie maken in therapie omdat hij zijn probleem sneller onderkent, open staat voor suggesties tot verandering en zelf vaak spontaan initiatief neemt om zijn probleem op te lossen.

Kunnen we dan niets teweegbrengen bij jongeren die niet zelf willen werken aan hun gedrag?

“Wanneer je als hulpverlener, na inschatting, besluit dat er geen motivatie aanwezig is, word je direct voor twee opties gesteld. Je kan direct besluiten, cru gesteld, dat de persoon die voor je staat niet veranderen wil, dus steek je er beter je tijd niet in. Ofwel kan je stellen dat het willen van die persoon net een resultaat kan zijn van jouw werk zelf. In dat geval start het motiverend werk.”

(Mark Tack, agora 23, nr. 5 pp 27)

Met dit citaat geeft Mark Tack aan dat willen veranderen geen stabiele eigenschap is van een jongere, maar het resultaat van een interactie tussen de omgeving en de jongere zelf. Soms zullen begeleiders een gebrek aan motivatie in de schoenen schuiven van de jongere zelf, die volgens hen “geen karakter heeft” of “er nog niet klaar voor is” (Vansteenkiste, 2003). Het toeschrijven van een gebrek aan geobserveerde gedragsverandering aan externe factoren alleen is zeer risicovol: het lijkt de begeleiders immers te ontslaan van elke verantwoordelijkheid, omdat vrij stabiele oorzaken bij de jongere zelf de oorzaak zijn van het blijven voortbestaan van het probleem. Als begeleiders een dergelijk defensieve verklaring bieden, is dit vaak omdat het veel moeilijker is om te erkennen dat de eigen therapiestijl of het gecreëerde klimaat in de afdeling aan de basis ligt van de gebrekkige vooruitgang van jongeren. Het erkennen van deze medeverantwoordelijkheid is immers veel bedreigender voor de begeleiding zelf. Het betekent namelijk dat men onderkent dat men fouten maakt en dat verandering soms noodzakelijk is.

Een dergelijke defensieve verklaring sluit ook niet aan bij de uitgangspunten van de ZDT. Deze stelt immers dat iedere persoon in zich de kracht draagt om aan zijn problemen op een constructieve wijze te werken, gegeven dat er voldoende ondersteuning komt vanuit de omgeving. Dit betekent dat elke begeleider een rol kan spelen in het motiveren tot duurzame gedragsverandering. Wat houdt dit motiverend werk dan in? Het houdt tijdens de therapie een verschuiving in van hopeloosheid of ‘moeten’ veranderen naar een ‘willen’ veranderen. Het doel bestaat er in om de jongere tot een persoonlijke overtuigde gedragsverandering te brengen, waarbij hij of zij persoonlijk het belang inziet van een gedragsverandering. Met andere woorden: de jongere aanvaardt de reden van de gedragsverandering. Zoals kan opgemerkt worden in

Figuur 1 bestaat de kern van het motiveren er in dat we de jongere helpen inzien wat het belang van de regels of de gedragsverandering nu precies is, zodat deze verschuift van het in therapie gaan omwille van externe verplichting (geen aanvaarding; moeten), via interne verplichting (gebrekkig aanvaarding; moeten) naar persoonlijk overtuigde verandering (volledige aanvaarding; willen). De vraag rijst dan ook onmiddellijk hoe we dit als begeleiders en therapeuten kunnen bewerkstelligen. Wat zeker is, is dat het een werk van lange adem is, dat tijd, geduld en heel veel energie vraagt. Binnen de ZDT wordt gesteld dat het aanbieden van een noodbevredigende context hierin van cruciaal belang is. Wat hier precies wordt mee bedoeld, proberen we in de volgende sectie te verduidelijken.

Hoe kunnen we deze persoonlijke aanvaarding stimuleren?

Hoe kunnen we de persoonlijke aanvaarding van het belang van bepaalde regels of gedragsveranderingen nu stimuleren? Zoals reeds vermeld in de inleiding vertrekt de ZDT van een positief mensbeeld (Deci, & Ryan, 2000). Mensen zijn actieve, groeigeoriënteerde organismen. Deze natuurlijke drang tot groei uit zich in de tendens om intrinsiek gemotiveerde activiteiten uit te voeren en in het proces van het persoonlijk aanvaarden of eigen maken van initieel extern gestuurde activiteiten. Dus, zowel passie als persoonlijke aanvaarding worden binnen de ZDT beschouwd als natuurlijke processen, die bij elke mens vanaf de geboorte aanwezig zijn.

Hoe komt het dan dat er zoiets bestaat als angst, depressie en psychopathologie? Om de inherente groeitendens te laten ontwikkelen is er 'voedsel' nodig. Ryan en Deci (2000) vergelijken het optimaal psychologisch functioneren van mensen met het optimaal fysiek groeien van een plant. Ook een plant heeft een potentiële groeitendens. Toch zal deze tendens niet tot uiting komen als deze plant in een omgeving groeit waar

geen water en geen zon aanwezig is. Met andere woorden, de plant heeft een aantal fysieke noden en als hier niet aan voldaan wordt, zal deze niet (verder) groeien. Zo is het ook met de mens. De mens heeft een aantal aangeboren noden, niet enkel fysiologisch maar ook psychologisch. Volgens de ZDT bestaan er zo drie psychologische basisnoden, waarvan de vervulling van fundamenteel belang is voor het psychologische welzijn en de groei van mensen. De drie onderscheiden behoeften zijn de nood aan Autonomie, wat verwijst naar een gevoel van psychologische vrijheid bij het uitvoeren van een activiteit; de nood aan relationele verbondenheid, wat verwijst naar een gevoel van geborgenheid en intimiteit ervaren en de nood aan Competentie, wat verwijst naar het gevoel te hebben de gewenste activiteiten tot een goed einde te kunnen brengen (Deci & Ryan, 2000). Deze drie noden kunnen gemakkelijk herinnerd worden met het acronym “ABC”. Als deze noden worden bevredigd zal het proces van persoonlijke aanvaarding worden aangewakkerd (zie Figuur 2), indien ze worden gefrustreerd zal deze inherente groeitendens tegengewerkt worden en kan er angst, onzekerheid, depressie en/of psychopathologie ontstaan (Ryan & Deci, 2000).

Er bestaat een belangrijk verschil in de dynamiek die fysiologische en psychologische noden kenmerkt, die klinische implicaties heeft: als aan een fysiologische nood niet wordt voldaan, zal men actief op zoek gaan in de omgeving om deze nood te bevredigen tot het ervaren tekort (bijv., honger) wordt gelenigd. Als aan een psychologische nood niet wordt voldaan, bestaat het risico dat men in een neerwaartse spiraal terecht komt. Men gaat “noodsubstituten” ontwikkelen die een compensatie vormen voor de ervaren psychologische noodfrustratie. Zo kan een kind dat weinig aandacht en warmte van de ouders krijgt en zelfs wordt verwaarloosd, waarbij zijn behoefte aan relationele verbondenheid dus op een chronische wijze wordt

gefrustreerd, leren om op een agressieve manier de aandacht te eisen. Het agressief opeisen van de aandacht van anderen kan gezien worden als een copingstrategie om te leren omgaan met een blijvende frustratie van de nood aan relationele verbondenheid. Hoewel dergelijke noodsubstituten een korte termijn positief effect kunnen hebben is het aannemelijk dat deze op lange termijn leiden tot meer noodfrustratie (Ryan & Deci, 2000). In het voorbeeld kan het agressieve gedrag van het verwaarloosde kind waarschijnlijk wel tijdelijk de aandacht van de omgeving uitlokken (wat beter is dan geen aandacht te krijgen), maar dergelijk agressief gedrag zal echter niet op lange termijn aandacht ontlokken. De verkregen aandacht werd immers slechts geboden omdat het moest; de omgeving had geen andere keuze dan de nodige aandacht te bieden omdat ze zich door de agressieve opstelling van de jongere met de rug tegen de muur voelden geplaatst. Omdat de geboden aandacht echter niet spontaan en authentiek was, is het aannemelijk dat de externe omgeving het bieden van aandacht niet volhoudt. Deze verminderde aandacht gaat gepaard met een verdere gebrekkige bevrediging van de nood aan verbondenheid bij de jongen, wat op zich weer het agressieve gedrag in de hand kan werken. Dit alles geeft aan dat jongeren in het geval van chronische noodfrustratie in een negatieve spiraal kunnen terecht komen, waarbij ze zich vastbijten in noodsubstituten die zelf gepaard gaan met minder noodbevrediging. Deze verminderde noodbevrediging ontlokt op zijn beurt een versterkte focus op noodsubstituten uit en zet zo de negatieve spiraal verder.

Wat kan deze neerwaartse spiraal dan helpen doorbreken? Volgens de ZDT is het de taak van de therapeut om een noodbevredigende context aan te bieden, ofwel door deze noden zelf te gaan bevredigen in het therapeutische proces of suggesties te doen hoe de cliënt in zijn dagelijkse leven kan proberen om meer noodbevredigende

activiteiten te gaan uitvoeren. Noodbevrediging vormt dus de nodige brandstof voor het op groei gericht organisme om zich in positieve zin te herstellen. Deze brandstof wordt aangeleverd door de externe omgeving, die in voortdurende interactie staat met de cliënt. Als begeleiders de jongere dus helpen om diens noden te bevredigen, zal jongere sterker gestimuleerd worden om het belang van de regels en gedragsverandering te aanvaarden. Hij geraakt meer persoonlijk overtuigd van het belang van gedragsverandering, wat een betere garantie biedt op langdurig succes. In wat volgt gaan we meer concreet in op hoe de externe omgeving op de drie basisbehoeftes kan inspelen.

De Nood aan Competentie

Zoals reeds aangehaald verwijst de nood aan competentie naar het aanvoelen en de positieve verwachting om een gewenst resultaat neer te zetten. Als een cliënt denkt een bepaald vooropgesteld doel niet te kunnen bereiken, zal hij ook niet starten met het langdurige en intensieve leerproces.

“Een rode draad in alle begeleiding met zowel drinkers, druggebruikers, de ouders en de partners van de gebruikers, is dat we hen ondersteunen in hun zelfwaarde, wat op zich een zeer motiverend gebeuren is. Naast de last van de mensen moet er ook het gevoel zijn dat ze er toch nog iets mee kunnen doen: dat ze zelf de moeite waard zijn er iets mee te doen!”

(Thomas Van Reybrouck, agora 23, nr. 5 pp30)

Competentie is noodzakelijk voor elke vorm van motivatie. Als men het gevoel heeft dat men het niet zal kunnen, zal men immers hulpeloos worden. Men verliest het zelfvertrouwen, waardoor men passief wordt.

“Ja, winstervaringen die in de loop van het proces ontstaan spelen een grote rol, maar ook de ‘het-kan’-ervaring’. Mensen willen soms niet van gedrag veranderen omdat ze angst hebben voor de mislukking”

(Mark Tack, agora 23, nr. 5 pp31)

Om deze nood te bevredigen is het belangrijk dat er in de sociale omgeving de nodige houvast of structuur geboden wordt, zodat cliënten weten *wat* er van hen verwacht wordt en *hoe* ze de opgedragen verwachtingen kunnen inlossen (Vansteenkiste, et al., 2007).

Een aantal tips om de bevrediging van competentie op het niveau van de organisatie te realiseren zijn:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Duidelijke en consistente regels en verwachtingen opstellen- Deze regels en verwachtingen helder en duidelijk communiceren- Consequent optreden bij het overtreden van gemaakte afspraken |
|---|

Een competentie-ondersteunend klimaat is dus het omgekeerde van een chaotisch of ‘laissez-faire’-klimaat. Dit laatste kenmerkt zich door het geven van totale vrijheid, waarbij een gebrek aan structuur zorgt voor onvoorspelbaarheid en onzekerheid. De ene keer zal er hierbij worden ingegaan op het overtreden van de gemaakte afspraken, terwijl dit de andere keer niet wordt gedaan (Vansteenkiste, Soenens, Sierens, & Lens, 2005).

Naast het algemene klimaat in een instelling kan de behoefte aan competentie ook bevredigd worden via de concrete omgangsstijl van de begeleiding. Een aantal tips om de nood aan competentie in de interactie tussen de begeleider en de jongere te bevredigen zijn:

- Vooropstellen van realistische, maar toch uitdagende doelstellingen
- Grote uitdagingen opdelen in meer realistische tussenstappen
- Tips geven op moeilijke momenten
- Positieve feedback geven omtrent de vaardigheden van de cliënt
- Aanreiken van werkpunten
- Vertrouwen en geloof communiceren dat veranderingen haalbaar zijn

Door realistische, maar toch uitdagende doelstellingen voorop te stellen maakt men het veranderingsproces optimaal uitdagend (Deci & Ryan, 1985), terwijl men door het geven van tips en positieve feedback het zelfvertrouwen van de cliënt in diens vaardigheden verhoogt. Ook het aangeven van werkpunten zal belangrijk zijn, zodat de cliënt weet op welke manier hij/zij verder kan werken aan zichzelf.

Merk op dat tal van motivationele technieken en principes die centraal staan binnen Motivationeel Interviewen (Miller & Rollnick, 2002) ook de behoefte aan competentie zullen frustreren of bevorderen (Vansteenkiste & Sheldon, 2006). Zo zal het diagnosticeren en labellen van jongeren als “probleemjongeren” hun zelfvertrouwen en het geloof in zichzelf ondermijnen. Het bieden van een samenvatting op het einde van een gesprek kan daarentegen ervoor zorgen dat cliënten meer houvast krijgen en een beter vat hebben op de situatie, waardoor zijn/haar waargenomen competentie verhoogd wordt, het vertrouwen groeit en de cliënt meer persoonlijk overtuigd geraakt van de zinvolheid van de veranderingen.

De nood aan Autonomie

Autonomie wordt gedefinieerd als de mate waarin gedrag geïnitieerd en uitgevoerd wordt met een gevoel van psychologische vrijheid (Deci & Ryan, 2000).

Volgens de ZDT hebben mensen nood aan autonomie, met andere woorden aan het stellen van gedrag dat goed aansluit met de eigen ideeën, waarden, doelen en interesses.

Waar het bij een competentie-ondersteunende omgeving gaat om het hebben van een duidelijke structuur, is de manier of wijze waarop die structuur wordt aangeboden of wordt geïnstalleerd belangrijk voor een autonomie-ondersteunend klimaat. Eén belangrijk kenmerk van een dergelijk autonomie-ondersteunend klimaat is het aanbieden van keuze en het bieden van inspraak, een motivatiestrategie waarvan het belang ook in de klinische praktijk wordt herkend, zoals blijkt uit onderstaande citaat:

“In de motiveringstechniek zijn er altijd opties waaruit mensen zullen moeten kiezen... Het is belangrijk dat mensen ruimte krijgen om zowel de inhoud, de vorm, de zingeving, de richting mee te bepalen.”

(Mark Tack, agora, 23, nr. 5 pp42)

Op het niveau van de organisatie van een residentiële instelling, kunnen maatregelen eerder autonomie-ondersteunend dan wel controlerend zijn. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:

Autonomie-ondersteunende maatregelen	Controlerende maatregelen
- Structureel inbedden van keuzes - Verlenen van inspraak aan de cliënt - Inbouwen van een motivationele fase in therapie	- Belonen en straffen voor goed/slecht gedrag - Kritisch evalueren van patiënten - Opleggen van doelstellingen - Systematisch opleggen van deadlines

Het systematisch inbouwen van controlerende maatregelen zorgt ervoor dat het gedrag of de gedragsverandering van de cliënten gestuurd wordt door externe elementen en de externe verplichting dus verhoogd wordt. De druk tot verandering kan bijvoorbeeld opgedreven worden door doelstellingen in de behandeling zelf op te leggen, een tijdsultimatum te stellen waarbinnen vooruitgang zichtbaar moet zijn, en cliënten te belonen of sanctioneren voor het (niet) bereiken van deze doelstellingen. Door zoveel mogelijk keuzemogelijkheden in te bouwen en inspraak te verlenen aan de cliënt wordt de betrokkenheid van de cliënt verhoogd en zal hij ook zelf meer achter de regels en de gedragsverandering staan. Een instelling kan er ook voor kiezen om in het begin van de therapie een motivationele fase in te bouwen, waarbij cliënten de kans krijgen om *niet* te veranderen en hun probleemgedrag verder te zetten. Dit betekent dat cliënten aanvankelijk bijvoorbeeld gewoon kunnen meekijken en observeren (kijktherapie) om te zien hoe de therapie verloopt. Na een aantal weken kunnen zij vervolgens beslissen of de aangeboden therapievorm aansluit bij wat ze zelf willen en of ze in therapie wille gaan. Deze motivationele fase dient dus om hen verder te laten nadenken of contempleren (cfr. Transtheoretisch model van verandering) over de noodzaak van verandering om hen dan de vrije keuze te bieden om al dan niet in

behandeling te stappen. Iemand kan slechts keuze ervaren voor zover er ruimte bestaat om te kiezen; dit betekent dat men kan kiezen om niet in behandeling te gaan.

Opvoedkundigen en therapeuten kunnen in de directe omgang met cliënten ook meer of minder autonomie-ondersteunend dan wel controlerend te werk gaan:

Autonomie-ondersteunende interactie	Controlerende interactie
- Controlerende of dwingende taal vermijden - Zinnige uitleg / rationale geven - Discrepantie-inducerend werken - Reflectief luisteren - Empathisch zijn	-Dwingende taal (“Je moet...” “Ik verwacht...”) -Inspelen op interne gevoelswereld (angst, schaamte, schuld, ...) -Inspelen op het zelfwaardegevoel

Een meer controlerende of autoritaire vorm van omgang tussen de begeleider en cliënt staat het persoonlijk aanvaarden van verandering in de weg. De therapeut zal druk zetten op de cliënt tot verandering door een dwingende taal te hanteren, waarbij woorden als “moeten” en “verwachtingen” vaak worden gebruikt. De begeleiding zal bij falen duidelijk ontgoocheling laten blijken in plaats van empathisch mee te leven in de reden voor het falen. Deze ontgoocheling zal inspelen op een schuldgevoel en dus de interne verplichting van de cliënt om zich te herpakken. Deze hernieuwde pogingen zijn echter gekenmerkt met gevoelens van verplichting en stress, want het is zijn laatste kans om zich te bewijzen.

Een meer autonomie-ondersteunende interactie zorgt er daarentegen voor dat de cliënt beter begrijpt waarom de opgedragen regels of activiteiten van belang zijn, waardoor hij er ook sneller van overtuigd geraakt. Hierdoor kan de cliënt deze regels op een authentieke of autonome manier naleven, zonder gevoelens van dwang of verplichting te ervaren.

Door reflectief te luisteren, een techniek die naar voren wordt geschoven binnen Motivationeel Interviewen (Miller & Rollnick, 2002) waarbij de begeleider het verhaal van de cliënt naar hem terugkaatst, zal het zelfbewustzijn en inzicht in het eigen functioneren bij de cliënt toenemen, waardoor hij/zij een beter geïnformeerde en weloverwogen keuze kan maken. Al doende zal de hulpverlener ook empathisch het perspectief van de cliënt proberen in te nemen, waardoor de cliënt zich beter begrepen voelt en op een meer welwillende wijze aan zijn problemen wil werken.

Merk op dat een dergelijke autonomie-ondersteunende stijl kan helpen om de betekenis van bepaalde regels, die beogen de nodige structuur aan te brengen in een instelling, te duiden. Als een cliënt bijvoorbeeld verboden wordt om in het weekend naar huis te gaan, dan kan een dergelijk verbod meer of minder dwingend overkomen, afhankelijk van de wijze waarop het wordt meegedeeld. Indien de hulpverleners aangeeft dat hij begrijpt dat het moeilijk is voor de cliënt dat hij niet naar huis mag in het weekend of als hij de zinvolheid van deze regel verder probeert te verduidelijken, dan is de kans groter dat het verbod minder controlerend overkomt en dus minder weerstand en rebellie in de hand werkt. Dit voorbeeld geeft aan dat zelfs gemiddeld dwingende maatregelen (bijv. een verbod) op een relatief autonomie-ondersteunende wijze kan worden ingevoerd, wat de kwaliteit van de motivatie en de kans op duurzame gedragsverandering zal verhogen.

De Nood aan Verbondenheid

De nood aan verbondenheid, ofwel de nood om geborgenheid en intimiteit te ervaren, speelt tevens een belangrijke rol in het proces van persoonlijke aanvaarding (Deci & Ryan, 2000). Op het niveau van de organisatie kan men regels invoeren die meer bevorderend zijn voor de onderlinge verbondenheid en groepsfeer. Men kan bijv.

werken met leefgroepen, waarbij de jongeren samengebracht worden en ervaringen uitwisselen, zodat ze ook weten dat ze niet alleen staan met hun problemen, iets wat ook door Thomas Van Reybrouck (2007, p.38), wordt onderkend.

“Door een groep samen te zetten creëer je ook een soort nieuwe context die dan steun geeft voor het stoppen... Een groep is bij uitstek een forum waar mogelijkheden en benaderingen worden getoond, uitgesproken en aan mekaar gewogen kunnen worden”

Ook groepsactiviteiten kunnen bijdragen aan de groepssfeer. Verder kunnen nieuwe cliënten via een systeem van meter- of peterschap opgevangen worden door een peter en meter, die reeds een tijd in de instelling verblijft. Dit zorgt ervoor dat nieuwe cliënten zich welkom voelen en op hun meter of peter een beroep kunnen doen bij moeilijkheden. Het uitwisselen van expertise en hulp zal tevens de behoefte aan competentie van de peter of meter bevredigen.

Op het niveau van de communicatie is een empathische en respectvolle houding ten aanzien van de cliënten steeds belangrijk. De grote uitdaging hierbij is deze empathische en respectvolle houding ook te behouden in periodes van rebellie en verzet. Dit wordt mooi verwoordt in volgend citaat (Tack, 2007, p.42):

“Je hoeft niet bij het uitvoeren van alle opties mee tot in de finale gaan. In een keuzedilemma proces neem je zo een cliënt mee tot aan een kruispunt. Sommigen slaan een straat in waar je niet mee kunt gaan, maar goed, je kan elkaar terug zien aan het kruispunt als de cliënt er weer anders over denkt.”

Sommige begeleiders hebben immers enkel aandacht en respect voor cliënten als deze zich gedraagt zoals de begeleider dit verwacht. Wanneer de cliënt zich verzet tegen bepaalde regels, kan de hulpverlener bijvoorbeeld zeggen dat “hij/zij dat niet verwacht had” of dat “hij/zij teleurgesteld is in de matige vooruitgang van de cliënt”. Omgekeerd

hebben sommige begeleiders enkel aandacht voor hun cliënten voor zover deze een probleem hebben en dus de rol van cliënt opnemen. Impliciet wordt de boodschap gegeven “Ik ben in jou geïnteresseerd, niet als persoon, maar voor zover ik jou kan helpen.” In beide gevallen is er sprake van voorwaardelijke aandacht en niet-gratuit; de betrokkenheid van de begeleider wordt immers met een controlerend “sausje” overgoten. Door een respectvolle en empathische houding te behouden, ook op momenten dat het moeilijker loopt, voelt de cliënt zich ondersteund en begrepen en zal hij of zij ook openstaan om de therapeutische veranderingen persoonlijk te aanvaarden.

Conclusie

De ZDT is een motivationele theorie die uit de wetenschappelijke literatuur is gegroeid. Toch hopen we dat deze bijdrage duidelijk maakt dat deze theorie concrete handvaten te bieden heeft voor de praktijk. De pogingen om Motivationeel Interviewen, een motivatietheorie die gegroeid is uit de klinische praktijk, en de ZDT te integreren (zie bijv., Vansteenkiste & Sheldon, 2006) geeft aan dat de ZDT een toegevoegde klinische waarde heeft. Bovendien kan de theorie, dankzij zijn sterke diepgang en sterk uitgewerkt theoretisch kader, meer duidelijkheid brengen in wat goede en slechte motivatie betekenen en wat (de)motiveren nu precies inhoudt.

In dit opzicht stelt de ZDT dat de kwaliteit van motivatie een belangrijke rol speelt in het al dan niet bereiken van therapeutisch succes. Willen veranderen gaat gepaard met meer inzet in de therapie en bijgevolg meer gedragsverandering. Bovendien wordt het welzijn van de cliënt verhoogd. In de bijzondere jeugdzorg komt de hulpvraag meestal niet van de cliënt, maar van diens omgeving. Op deze manier wordt veeleer het moeten veranderen in de hand gewerkt, wat zich ofwel vertaalt in het kortstondig en slaafs uitvoeren van de opgedragen gedragsverandering of het zich

agressief verzetten tegen de opgedragen gedragsverandering. Toch is een therapie, waarbij vele patiënten het gevoel hebben dat ze moeten veranderen, niet gedoemd om te mislukken. Door in de klinische setting de noden aan competentie, autonomie en verbondenheid te bevredigen, zal het proces van persoonlijke aanvaarding gestimuleerd worden en zal de cliënt verschuiven van een gedwongen opname naar een meer persoonlijke overtuigde verandering, wat gepaard gaat met een sterk verminderd risico op herval.

Referentielijst

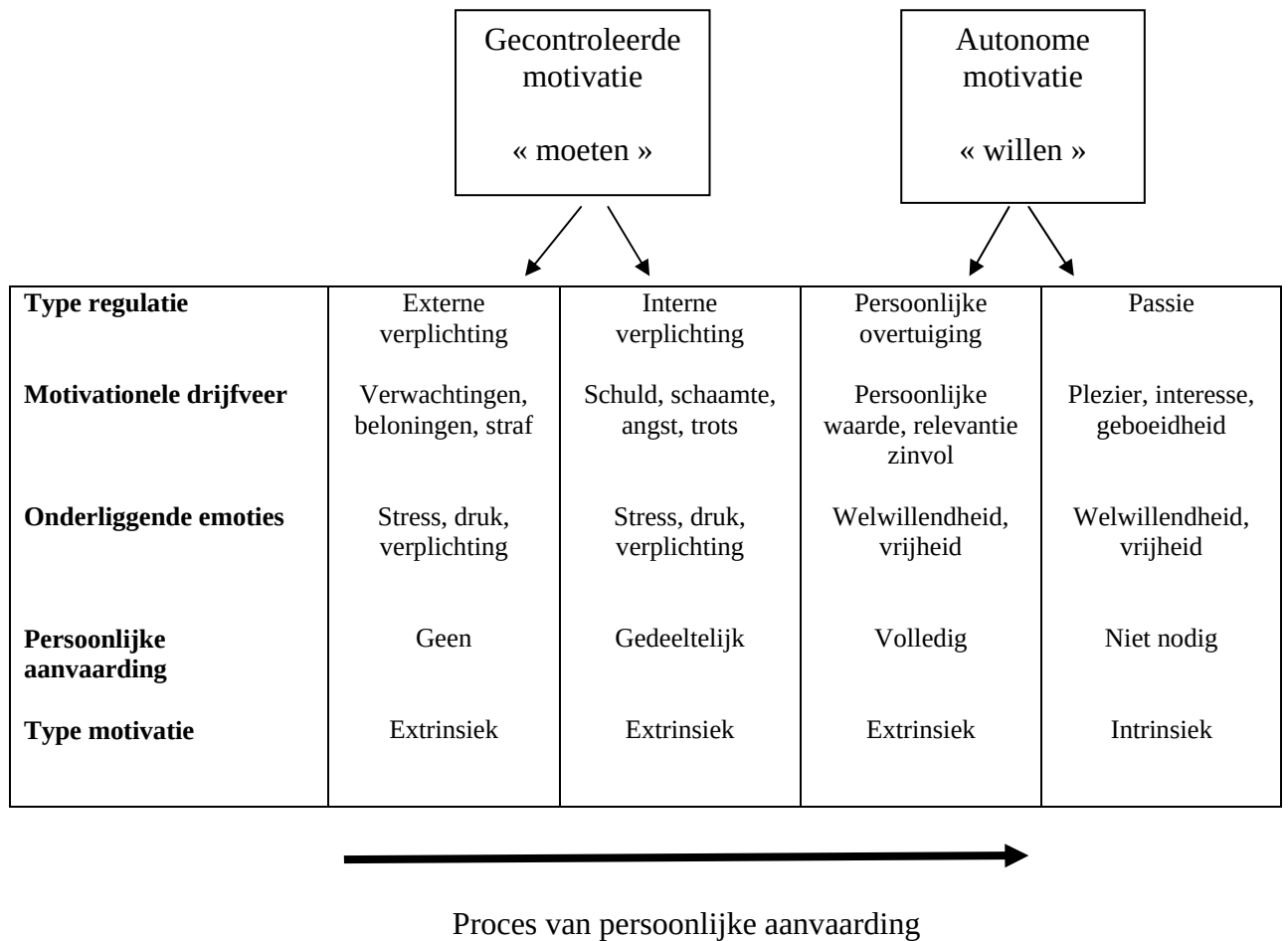
- Brecht, M. L., Anglin, M. D., & Wang, J. C. (1993). Treatment effectiveness for legally coerced versus voluntary methadone-maintenance clients. *American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 19, 89-106.
- Curry, S., Wagner, E. H., & Grothaus, L. C. (1990). Intrinsic and extrinsic motivation for smoking cessation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 58, 310-316.
- Deci, E.L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 18, 105
- Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self-determination perspective. *Journal of Personality*, 62, 119-142.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M., (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York, Academic Press.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11, 227-268.
- Diclemente, C. C. (1999). Motivation for change: Implications for substance abuse treatment. *Psychological Science*, 10, 209-213.
- Drieschner, K. H., Lammers, S. M. M, van der Staak, C. P. F. (2004). Treatment motivation: An attempt for clarification of an ambiguous concept. *Clinical Psychology Review*, 23, 1115-1137.
- Lens, W., & Depreeuw, E. (1998). *Studiemotivatie en faalangst nader bekeken: tussen kunnen en moeten staat willen*. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
- Miller, W. R., Benefield, G., & Tonigan, J. S. (1993). Enhancing motivation for change in problem drinking: A controlled comparison of two therapist styles. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 84, 455-461.
- Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). *Motivational interviewing*. New York: Guilford Press.
- Paredis, H. (2007). Hersenspinsel. *Agora*, pp23-24
- Pelletier, L. G., Tuson, K. M., & Haddad, N. K. (1997). Client motivation for therapy scale: A measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation for therapy. *Journal of Personality Assessment*, 68, 414-435

- Prochaska, J.O., Redding, C.A., Evers, K.E. (2002). The transtheoretical model and stages of change. In: K. Glanz, B.K. Rimer, F.M. Lewis et al (red.), *Health behaviour and health education: theory, research and practice*, 3rd edition, (pp. 99-120). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L., (2000) The darker and brighter sides of human existence: basic psychological needs as unifying concepts. *Psychological Inquiry*, 11, 319-338.
- Ryan, R. M., Plant, R. W. & O'Malley, S. (1995). Initial motivations for alcohol treatment- relations with patient characteristics, treatment involvement, and dropout. *Addictive Behaviors*, 20, 279-297.
- Senecal, C., Nouwen, A., & White, D. (2000). Motivation and dietary self-care in adults with diabetes: Are self-efficacy and autonomous self-regulation complementary or competing constructs? *Health Psychology*, 19, 452-457.
- Tack, M. & Van Reybrouck, T. (2007). Lessen in motiverend werken vanuit de ervaring van begeleiding in de verslavingszorg. In *Agora*, 26-43.
- Tierney, D. W., McCabe, M. P. (2002). Motivation for behavior change among sex offenders: A review of the literature. *Clinical Psychology Review*, 22, 113-129.
- Vansteenkiste, M. & Sheldon, K. M. (2006). "There's nothing more practical than a good theory": Integrating motivational interviewing and self-determination theory. *British Journal of Clinical Psychology*, 45, 63-82.
- Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur in de klas: over het stimuleren van een optimaal leerproces. *Begeleid Zelfstandig Leren*, 16, 37-58.
- Vansteenkiste, M., Soenens, B., Sierens, E., & Lens, W. (2005). Hoe kunnen we leren en presteren bevorderen? Een autonomie-ondersteunend versus controlerend schoolklimaat. *Caleidoscoop*, 17, 18-25.
- Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Vandereycken, W. (2005). Motivation to change in eating disorder patients: A conceptual clarification on the basis of self-determination theory. *International Journal of Eating Disorders*, 37, 207-219.

- Wild, T. C., Cunningham, J. A., & Ryan, R. M. (2006). Social pressure, coercion and client engagement at treatment entry: A self-determination perspective. *Addictive Behaviors*, 31, 1858-1872.
- Zeldman, A., Ryan, R. M. & Fiscella, K. (2004). Motivation, autonomy support and entity beliefs: Their role in methadone maintenance treatment. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 23, 675-696.

Figuur 1

Schematisch Overzicht van de Verschillende Types Motivatie volgens de Zelf-Determinatie Theorie, aangepast van Deci en Ryan (2000)



Figuur 2

Schematisch Overzicht van Drie Basisnoden en Ondersteuning in de Omgeving

